UNIVERSITÉ PRIVÉE DE MARRAKECH — UNIVERSITÉ RECONNUE PAR L'ÉTAT	Année universitaire : 2024-2025	FPMDM — FACULTÉ PRIVÉE DE MÉDECINE DENTAIRE DE MARRAKECH — UNIVERSITÉ PRIVÉE DE MARRAKECH
	Niveau : MED4	
	Examen Contrôle continu – avril 2025	
	Module : Maladies systémiques	Pr ESSAADOUNI L.

1- Quel mécanisme immunologique est principalement impliqué dans les lésions tissulaires observées dans le lupus systémique ?

A. Production des complexes immuns circulants
B. Activation des lymphocytes T auxiliaires par les interleukines
C. Production excessive d'anticorps IgE contre les antigènes environnementaux
D. Déplétion des cellules B régulatrice
E. Inhibition de la fonction des macrophages par les cytokines anti-inflammatoires

2- Parmi ces anticorps quels sont ceux qui sont les plus spécifiques du lupus systémique

A. Auto-anticorps anti-SSa
B. Anticorps antinucléaires
C. Anticorps anti-Sm
D. Anti-RNP ?
E. Anti scl70 ?

3- Parmi les complications cardiaques du lupus systémique, laquelle est la plus fréquente ?

A. Insuffisance cardiaque congestive
A. Péricardite
B. Thrombose intracardiaque
C. Endocardite
D. Valvulopathie

4-Parmi les auto-anticorps suivants, lequel est le plus spécifique de la sclérodermie systémique et est particulièrement associé à une atteinte pulmonaire sévère ?

A. Anticorps anti-Scl-70 (topoisomérase I)
B. Anticorps anti-centromères
C. Anticorps anti-RNA polymérase III
D. Anticorps anti-fibrilline
E. Anticorps anti-PM-Scl

5-La sclérodermie systémique peut entraîner une hypertension artérielle pulmonaire. Quel est le mécanisme principal responsable de cette altération vasculaire dans la sclérodermie ?

A. Vasodilatation excessive
B. Hypersensibilité à l'angiotensine II
C. Dysfonction endothéliale et vasoconstriction
D. Formation de complexes immuns circulants
E. Infiltration des parois vasculaires par des cellules T cytotoxiques

6-Parmi les complications de la sclérodermie systémique, quelle est celle qui est la plus fréquemment associée à un mauvais pronostic ?

A. Pneumopathie interstitielle diffuse
B. Trouble de la motilité oesophagienne
C. Embolie pulmonaire
D. Pneumonie infectieuse récurrente
E. Bronchite chronique obstructive

7-Quelle est la principale caractéristique clinique de la dermatomyosite ?

A. Éruptions cutanées et faiblesse musculaire proximale
B. Fièvre et douleur articulaire
C. Anémie et éruptions cutanées
D. Hypotension et troubles neurologiques
E. Parotidomégalie

8-Les 3 sites de prédilection de la granulomatose avec polyangéite sont :

A. Le poumon
B. Les articulations
C. L'appareil ORL
D. Le rein
E. Le foie

9- Le marqueur immunologique caractéristique de cette affection est:

A. L'anticorps-antinucléaire
B. Le C- ANCA de type PR3
C. Le P-ANCA de type MPO
D. Le facteur rhumatoïde
E. L'anticardiolipine

10- L'atteinte rénale au cours de cette affection

A. Est de type tubulo interstielle
B. Est de mauvais pronostic
C. Est pauci immune
D. Est responsable d'une glomérulonéphrite rapidement progressive
E. Est de type vasculaire

11- L'atteinte neurologique de cette affection

A. Est responsable d'AVC
B. Est à type de neuropathie périphérique ??
C. Est à type de pachyméningite
D. Est liée à la présence des antiphospholipides
E. Est liée à une vascularite

12-L'atteinte ophtalmologique de cette affection est une :

A. Uvéite ?? → Behcet.
B. Vascularite rétinienne
C. Sclérite
D. Névrite optique
E. Conjonctivite

13-Le traitement de cette patiente repose sur :

A. La colchicine
B. Les antipaludéens de synthèse
C. La corticothérapie
D. L'Endoxan
E. L'aspirine ??

14-Quels examens immunologiques sont caractéristiques du syndrome de Gougerot-Sjogren ?

A. Anti-SSA SSA et SSB
B. Anti- CCP
C. Anti- DNA ??
D. Anti-Sm
E. Anti-topoisomérase 1